SYSTEMES DE SANTE DANS LE MONDE

SYSTEMES DE SANTE

Historique

-Initialement activités relevant des professions médicales et des associations caritatives

-Après 2ème guerre mondiale:

Emprise des Etats sur le secteur de la santé avec développement de politiques sanitaires incontournables dans les décisions d'organisation et de financement

Définition(1).

Il y a plusieurs façons de définir le **système de santé**:

→ certaines étroites (**l'ensemble des activités** sous la **responsabilité** du **ministère de la santé**),

→ d'autres très larges (**toutes les activités** qui **améliorent la santé**).

Définition(2).

L'OMS se base sur le concept d'activité de santé pour la définition:

Le **système de santé** inclut tous les activités dont le but principal est de:

- **Promouvoir**
- **Restaurer**
- **Maintenir la santé.**

Système de santé (OMS, 2000)

*Trois objectifs

*Quatre fonctions

*Deux dimensions de chacun des objectifs

Objectifs

L'OMS (rapport de l'année 2000) assigne **trois objectifs** aux systèmes de santé :

1. **Améliorer** et **maintenir l'état de santé** de la population.
2. **Assurer la réactivité** du système.
3. **Garantir une contribution équitable** de la part de la société.

Objectif : réactivité

- La réactivité concerne la capacité du système à répondre aux attentes de la population quant à la façon dont elle souhaite être prise en charge :

- Certains systèmes de santé ont une réactivité faible : traitement impersonnel et inhumain des personnes, agents de santé grossiers et arrogants, délais d’attente pour les interventions chirurgicales non urgentes,etc.

Fonctions

Le rapport de l'OMS présente ***quatre fonctions*** du système de santé :

- **Prestation de services** (provision).
- C**réation de ressources** (Investissement et formation)
- **Gestion et administration du système** (Contrôle)
- **Financement** (collecte, mise en commun et achat).

Deux dimensions pour chaque objectif:

Niveau moyen obtenu (goodness)

Distribution (fairness)

Organisation économique du système de santé

* La plus part des systèmes européens allient une **pratique libérale** de la médecine avec un soutien des pouvoirs publics aux **soins en institutions** (hôpitaux, établissements pour malades chroniques) et un filet de **sécurité sociale** dense (via un système assuranciel)

*C'est un modèle «post bismarckien », ce que l'OMS appelle un« système pluraliste »

Flux financier du système de santé

OCDE, 2002

	Système de santé	
	Français	Suisse
Ménages privés	11%	28%
Assurances privées	12%	
Assurance maladie		48%
État	76%	15%

Performance

La **performance** d'un système de santé correspond à sa **capacité** à remplir les **missions** pour lesquelles il est considéré comme responsable.

*Performance du **système de soins.**

*Performance du **système de santé.**

(Pourquoi les systèmes de santé qui disposent de **ressources similaires** atteignent des **résultats très différents?)**

*Performance des **interventions** autres que celles relevant du système de santé.

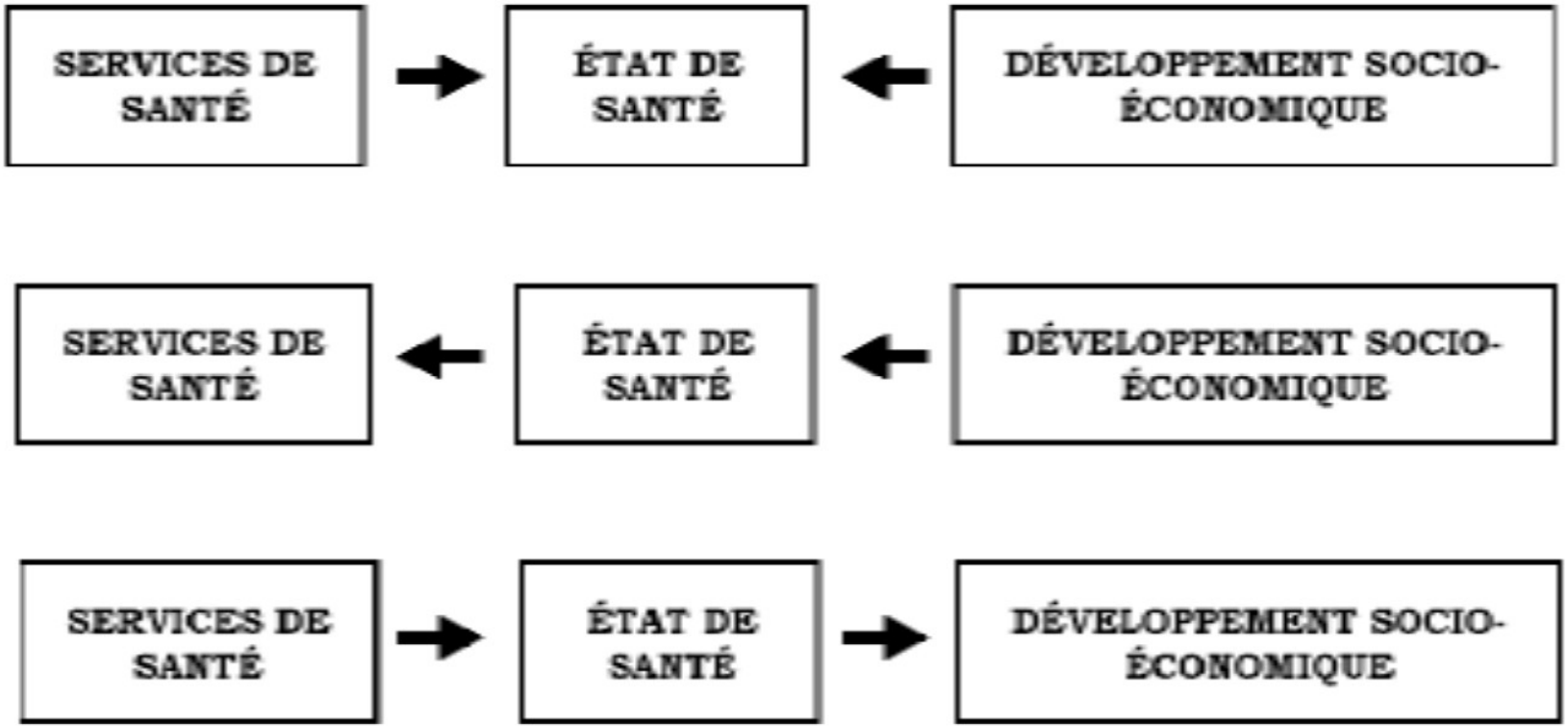
Projet

On appelle **projet l'ensemble des actions** à entreprendre afin de répondre à **un besoin défin**i dans des **délais** fixés.

Ainsi un projet étant une **action temporaire** avec un début et une fin, mobilisant des **ressources** identifiées (humaines et matérielles) durant sa réalisation, celui-ci possède également un **coût** et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant de celui de l'entreprise.

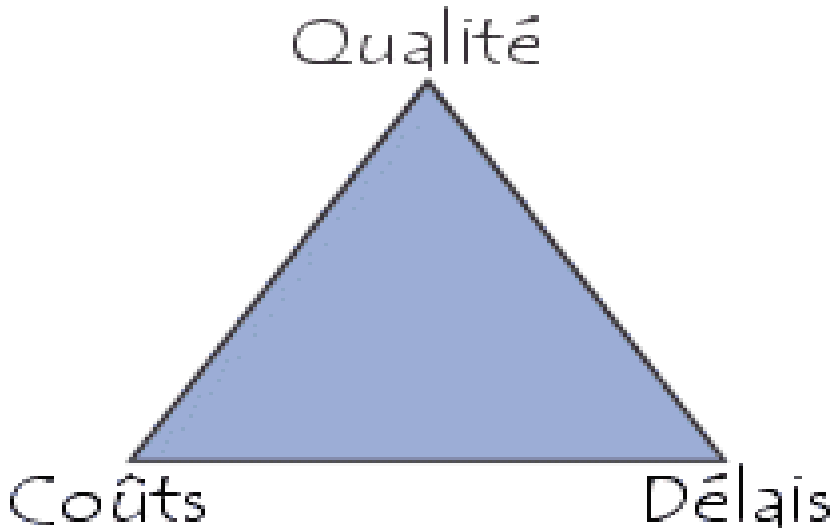
On appelle «**livrables**» les résultats attendus du projet.

Performance des services de santé



Triptyque:objectifs –coûts - délais

Qualité=Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences.



il est essentiel d'établir un plan de formation permettant à la maîtrise d'oeuvre et à la maîtrise d'ouvrage d'avoir un langage commun.

Systèmes de sante

- Situation tres variee d ’un pays a l ’autre

  - Inexistence d ’un système de sante pur présentant de nettes limites de démarcation

  - Cumul de différents types avec dosages différents

- Nécessite d ’une typologie des systèmes de sante

SYSTEMES DE SANTE

- TROIS GRANDS TYPES DE SYSTEMES

- Systèmes libéraux

- Systèmes nationalisés (publics)

- Systèmes intermédiaires

Les systèmes libéraux

Caractéristiques

-prédominance de l'exercice libéral surtout en ambulatoire

-financement à base de caisses d 'assurances privées

-paiements directs des usagers

-mécanisme de paiement dominant
c 'est le paiement à l'acte

Les systèmes libéraux (suite)

-Mode libéral dominant mais existence d ’un secteur public certes moins important mais en développement avec subventions étatiques de plus en plus importantes.

-Programmes spécifiques et financement gratuit pour les pauvres et personnes âgées.

Les systèmes nationalises

- Universalité de la couverture

- Financement étatique budgétisé, basé sur la fiscalité

- Accès gratuit

Les systèmes nationalises (suite)

- Secteur public prédominant mais existence d ’un secteur privé notamment en ambulatoire

- Mécanismes de rémunération:

  * Dotation budgétaire publique
  * Paiement à la capitation

Les systèmes intermédiaires

- Couverture universelle basée sur la sécurité sociale
- Exercice de la médecine libérale essentiellement en milieu ambulatoire
- Financement par cotisations sociales avec prélèvement obligatoire
- Régime général prévalant: assurance-maladie

Systèmes de sante

Panorama des systèmes

Pays représentatifs

-Libéraux (USA, Suisse), (DNS:12-15% du PIB)

-Nationalisés (Grande Bretagne, Suède, Norvège, Danemark, Canada), (DNS: 6-7% du PIB)

-Intermédiaires (France, Allemagne, Japon, Italie, Pays Bas), (DNS: 8-9% du PIB)

Panorama des systèmes (suite)

Etat de sante de la population

- Systèmes libéraux (état bon avec existence d ’une frange de population marginalisée)

- Systèmes nationalisés (état bon mais avec de longues attentes pour hospitalisations)

- Systèmes intermédiaires (état bon en général)

Panorama des systèmes (suite)

Avantages et inconvénients *(critères)*

1-niveau de DNS rapportée au PIB

- Systèmes libéraux (niveau élevé, forte évolution des dépenses)

- Systèmes nationalisés (niveau maîtrisé, évolution circonscrite dans des proportions raisonnables)

- Systèmes intermédiaires (niveau moyen, plusieurs mesures pour maîtrise de l ’évolution des dépenses)

Avantages et inconvenients *(suite)*

2- Accès des usagers bénéficiaires

-systèmes libéraux : (circonscrit aux seuls assurés et populations aisées, pauvres marginalisés)

-systèmes nationalisés : (couverture universelle touchant la totalité de la population)

-systèmes intermédiaires : (couverture universelle, populations marginalisées réduites)

Avantages et inconvenients*(suite)*

3-Temps de réponse à la demande

- Systèmes libéraux : (rapide et efficace)

-Systèmes nationalisés : (délais longs pour les rendez-vous, files d ’attente)

-Systèmes intermédiaires : (rapide et efficacité moyenne liée au niveau des équipements)

Avantages et inconvenients *(suite)*

4- Qualité

-Systèmes libéraux (élevée)

-Systèmes nationalisés (moyenne)

-Systèmes intermédiaires (au- dessus de la moyenne)

Avantages et inconvenients *(suite)*

5- Rentabilité (gaspillage ressources)

- Systèmes libéraux (élevée)
- Systèmes nationalisés (inefficacité allocative et inefficacité opérationnelle, forte bureaucratie)
- Systèmes intermédiaires (moyenne)

Avantages et inconvenients (*suite et fin)*

6- Tendances des réformes

-Systèmes libéraux (meilleure prise en charge des populations marginalisées, usage rationnel des ressources publiques.)

- Systèmes nationalisés (appelés à introduire plus de rigueur et de rationalité dans la gestion des ressources.)

- Systèmes intermédiaires (réformes visant à maîtriser les dépenses, introduction gestion rigoureuse)

Situation démographique, sanitaire et éducation - emploi -chômage et question genre

-- Transition **démographique** [42 millions habitants]: baisse taux de croissance (1,5% en 2006) et début processus de vieillissement (Espérance de vie 75 ans en 2006)

-- Transition **sanitaire** (amélioration état de santé, apparition maladies chroniques, émergentes)

-- **éducation, enseignement supérieur** (taux scolarisation 97% et 700.000 étudiants), faiblesse de la qualité d'enseignement

-- **emploi :** taux de chômage encore élevé (12%), chômage de jeunes, de diplômés, de primo demandeurs

Le système de santé Algérien

Plan du cours

1/Organisation administrative

a/Services centraux de l'Etat.

b/Services déconcentrés de l'Etat.

c/Services décentralisés de l'Etat.

2/Personnel de santé

a/Les médecins

b/Les paramédicaux

3/Etablissements de santé publique

a/Classification CHU,EHU,EHS,EH,EPH,ESPS

b/Le schéma d'organisation sanitaire.

c/Organes des établissements publics de santé

INTRODUCTION

- La Constitution consacre le champ de responsabilité dévolu à l'Etat. Elle dispose à cet effet en son article 54: **"Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques."** En outre, la législation depuis 1993 met également à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis non assurés sociaux, de formation et de recherche.
- L’ accès à la santé est. un droit pour chaque individu dans notre société.
- C’est à l’Etat qu’il revient de garantir à chaque individu, quels que soient ses moyens financiers, son lieu de résidence et son origine, l’accès à des soins de qualité dans le cadre de la solidarité nationale.

Quelques données au lendemain de l'indépendance

_ 500médecins (dont 50 % d'Algériens) pour une population de 10,5 millions d'habitants.

_ une mortalité infantile élevée (180 ‰),

_ une espérance de vie qui n'atteignait pas 50 ans

_ des maladies transmissibles sévissant à l'état endémique, d'une ampleur sans égale, responsables d'une importante

cause de décès et de handicaps.

→2 objectifs

_ lutter contre les maladies transmissibles

_ et développer l'accès aux soins.

1/organisation administrative

Services centraux de l'Etat.

Décret exécutif n° 11-380 du 21 novembre 2011 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Services déconcentrés de l'Etat.

Services décentralisés de l'Etat.

services centraux de l'Etat



Les Directions Générales

- Direction de la population,
- Direction des études et de la
- Direction de la pharmacie et des
- Direction des établissements de santé
- Direction de la santé, de la

Les Directions Générales(suite)

Services d’appuis du MSP/RH

ANDS

Agence Nationale de Documentation de la Santé

ANS

Agence Nationale du Sang

CNT

Centre National de Toxicologie

ENMAS

École Nationale de Management

et de l'Administration de la Santé

INPFP

Institut National Pédagogique de Formation

Paramédicale

INSP

Institut National de Santé Publique

IPA

Institut Pasteur d'Algérie

LNCPP

Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques

PCH

Pharmacie Centrale des Hôpitaux

Services décentralisés

La décentralisation consiste à transférer certaines **compétences** de l'autorité centrale (ou d'instance hiérarchiquement subordonnées) à des organes locaux qui ne dépendent pas d'elle.

La décision est prise au nom et pour le compte de la personne morale de droit qui bénéficie du transfert de compétence et non plus au nom de l'état ;.

1. Organes régionaux:
   - Conseils régionaux
   - Observatoire régionales
   - CHU
2. Organes locaux:
   - EHU
   - EPH
   - EPSP

Services déconcentrés de l'Etat.

Définition : déconcentration :

La déconcentration suppose le transfert d'une certain **pouvoir décisionnel** à des représentants locaux soumis au pouvoir hiérarchique du pouvoir central. Le pouvoir central décide toujours pour les affaires locales, mais décide sur place et non plus de la capitale.

La déconcentration est un aménagement technique plus ou moins poussé de la centralisation.

Direction de la **S**ante et de la

Population (DSP)

représentée dans les 48 wilayas

Chargées des **activités:**

-veillez à l'application de la législation et de la réglementation dans tous les domaines liés aux activités de santé et de population

-animer ,coordonner et évaluer le fonctionnement des structures de santé

-établir les autorisations relatives à l'exercice des professions santé et d'en assurer le contrôle.

-superviser et de veiller au bon déroulement des concours et examens professionnels

2/Personnel de santé

Les médecins

Les paramédicaux

le Personnel administratifs, techniques et de services

Ressources humaines(année 2006)

Les personnels médicaux :

14 273 médecins spécialistes,

25 818 généralistes

9 684 chirurgiens dentistes

7 267 pharmaciens

Les personnels paramédicaux :

56 710 infirmiers diplômés d'état

22 040 brevetés

2 516 aides paramédicaux

Répartition des spécialistes

le ratio médecins spécialistes/population est peu significatif dans la mesure où le nombre de spécialistes varie d'une discipline à une autre.

les spécialités médicales	**7 210**
les spécialités chirurgicales	**4 957**
la radiologie et le laboratoire	**1 642**
les spécialités dentaires	**617**

la grande partie de ces spécialistes sont dans les quatre grandes métropoles du pays.

les personnels médicaux et paramédicaux (nombre par habitant)

	1966	1999	2005	2007
Médecins	**1/8 112**	**1/1 177**	**1/969**	**1/830**
Généralistes		**1/1 750**	**1/1 708**	**1/1 373**
Spécialistes		**1/3 594**	**1/2 240**	**1/2 081**
Chirurgiens dentistes	**1/64 327**	**1/3 752**	**1/3 646**	**1/3 191**
Pharmaciens	**1/50 926**	**1/6 134**	**1/5 389**	**1/4 571**
Paramédicaux	**1/2 276**	**1/346**	**1/367**	**1/341**
Ratio PM/M	**3,56**	**3,40**	**3,40**	**2,43**

le ratio paramédicaux/médecins a tendance à diminuer.les normes de l'OMS proposent un ratio de 4. Cette diminution montre que la formation paramédicale reste insuffisante par rapport à la formation médicale.

Source : MSPRH et INSP

Personnel administratifs, techniques et de services

	1979	1995	2000	2006
Administratif	**2 062**	**13 077**	**13 991**	**14 222**
Technique	**722**	**928**	**1 855**	**9 178**
De service	**5 024**	**44 197**	**43 406**	**40 917**

3/Etablissements de santé publique

Depuis la réorganisation de 2007 supprimant le secteur sanitaire et **individualisant** les structures hospitalières du système avec :

→un établissement hospitalo-universitaire (EHU),

→des centres hospitalo-universitaires (CHU),

→des établissements hospitaliers spécialisés (EHS),

→des établissements publiques hospitaliers (EPH)

→et des établissements publics de santé et de proximité (EPSP),

Le secteur sanitaire étatique en plein essor et dominant avec un secteur privé (cabinets ,laboratoires et cliniques) en développement spectaculaire

Pas de textes concernant la hiérarchisation des soins et précisant les relations entre ces différentes structures publiques.

a/ Structures hospitalières

→**Les structures universitaires** accueillent les étudiants en médecine durant leur cursus. Il existe un établissement hospitalo-universitaire à Oran, dont le statut est différent du statut des centres hospitalo-universitaires.

→**Les établissement hospitaliers spécialisés** ont en principe pour vocation d'accueillir des patients relevant d'une spécialité. En fait, ces hôpitaux qui abritent différentes spécialités (cardiologie, maladies infectieuses, neurologie, orthopédie, psychiatrie, rééducation…) peuvent héberger des services universitaires.

→**Les établissements publiques hospitaliers** sont des hôpitaux qui n'ont pas de fonction universitaire et sont équipés pour faire face aux besoins d'hospitalisation de la population. Ils regroupent au moins quatre services cliniques de base (chirurgie, gynécologie-obstétrique, médecine interne), un plateau technique et des consultations

→ **les maternités** peuvent être autonomes, intégrées dans une polyclinique ou un centre de santé.

Evolution des lits

Evolution du nombre de ces structures hospitalière entre 2005 et 2007du secteur public :

Infrastructures hospitalières	2005		2006		2007	
	Nombre	Lits	Nombre	Lits	Nombre	Lits
EHU	1	740	1	740	1	740
CHU	13	13 837	13	12 697	13	12 697
EHS	32	6 046	36	7 306	54	9 785
EPH	232	33 837	234	33 977	240	35 157
Maternités	505	3 205	505	3 285	511	3 450
Total lits		57 665		58 005		61 829

C/structures extrahospitalières =EPSP

les Etablissements Publics de Santé et de Proximité englobent des polycliniques , des centres de santé et des salles de soins ainsi que certaines maternités publiques.

Évolution du nombre 2005-2007

	2005	2006	2007
Polycliniques	**517**	**524**	**1 477**
Centres de santé	**1 277**	**1 291**	**338**
Salles de soins	**4 533**	**4 533**	**5 117**

L'augmentation du nombre des polycliniques et la diminution du nombre de centres de santé en 2007 résulte du fait qu'avec la réorganisation de 2007 un certain nombre de centres de santé ont été érigés en polycliniques.

c/Infrastructures privées

Évolution 2005-2007

	2005		2006		2007	
	Nombre	**Lits**	**Nombre**	**Lits**	**Nombre**	**Lits**
Cliniques médico-chirurgicales et obstétricales	151	3 218	161	3 354	165	3 408
Cliniques médicales	23	26	23	65	23	65
Cliniques d'hémodialyse	48	577	58	581	64	643
Total lits		3 821		4 000		4 116
Total lits (%)		6,21		6,45		6,24

Infrastructures privées

	2005	2006	2007
Cabinets de consultation (généralistes)	5 990	6 102	6 208
Cabinets de consultation (spécialistes)	4 573	4 962	5 095
Cabinets de chirurgie dentaire	3 832	3 930	4 120
Officines pharmaceutiques	5 849	6 285	7 459
Laboratoires d'analyses médicales	267	278	286
Unités de transport sanitaire	85	124	141
Centres de procréation médicalement assistée	7	9	9

Statut

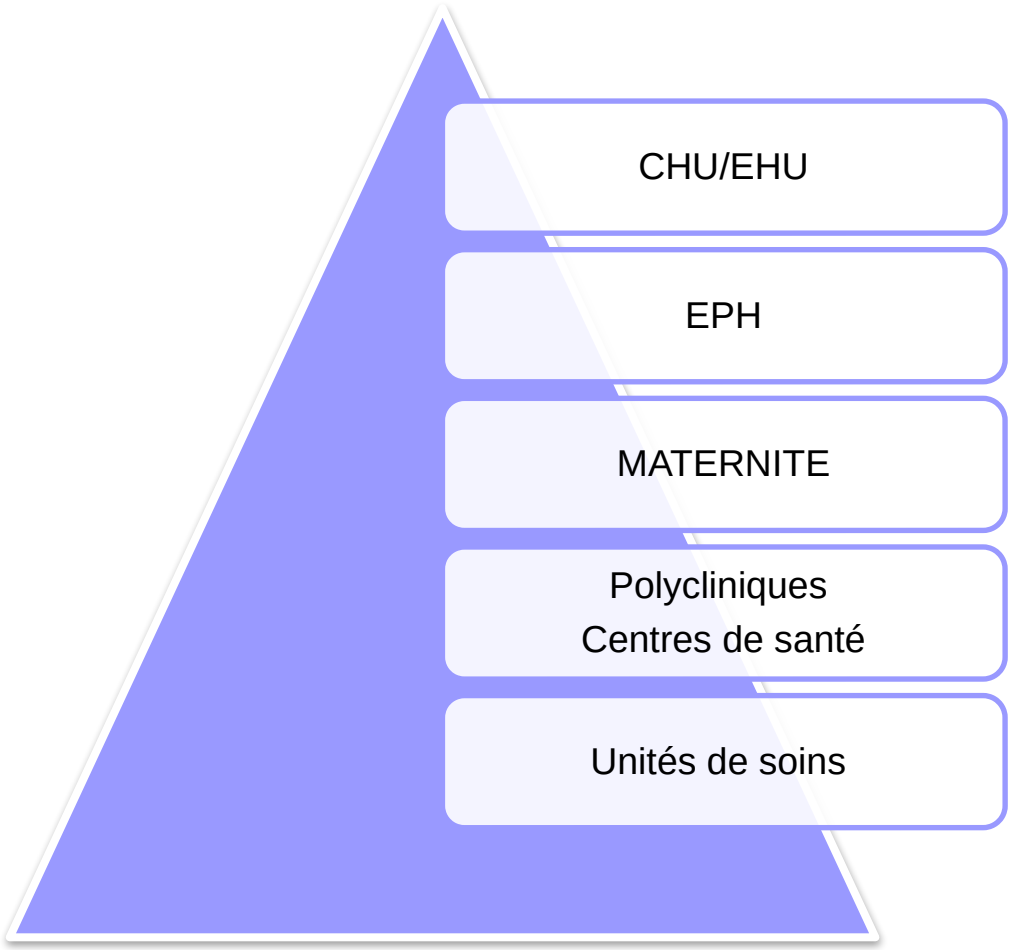
- Les établissements publics de santé sont dotés d'une personnalité morale de droit public et disposent de la capacité juridique (ils peuvent acquérir, vendre, posséder, et ester en justice)

- Ils sont placés sous la tutelle de l'Etat et de la DSP de Wilaya.

- Ils ont l'autonomie administrative et financière.

a/Classification des structures sanitaires

Le système national de santé doit être organisé pour prendre en charge les besoins en santé de la population de manière globale, cohérente et continue.



Classification des établissements publics selon le statut

ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE PROXIMITE	**USC** **CENTRE DE SANTE** **POLYCLINIQUE** **MATERNITE**	**Soins de santé de base** **Accouchement en milieu assisté**
ETABLISEMENTS HOSPITALIERS	**EPH** **EHS**	**Soins hospitaliers** **Soins psychiatriques**
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES	**EHU** **CHU** **EHS**	**Vocation régionale haute technicité** **spécialisation**

Classification des établissements publics selon le type des soins		
	Caractéristiques	Etablissements
Etablissements soins courte durée	soins intensifs (malades, blessés en phase aiguë et femmes enceintes)	CHU /EHU
		EPH SAMU
		POLYCLINIQUE(UM)
Etablissements soins de suite et réadaptation	Soins continus dans un but de réinsertion	EHS de rééducation fonctionnelle
		EHS SOINS PSYCHIATRIQUES
Etablissements soins longue durée	Pour des personnes n'ayant plus leur autonomie, surveillance médicale constante et traitement	CHU/EPH
		EHS

b/Organisation générale

- **<u>L'échelon central</u> :**

  Dix directions décret, coordonnées par le secrétaire général.
  des comités nationaux, sectoriels ou intersectoriels

  Des institutions au nombre de 10.

- **<u>L'échelon régional:</u>**

  La régionalisation sanitaire a été instituée en 1995**. le Conseil Régional de la Santé** est un organe consultatif, les Observatoires Régionaux de la **Santé (ORS), virtuel,**

- **<u>L'échelon de la wilaya:</u>**

  (48) **Direction de la Santé et de la Population; CHU (15); 186 secteurs sanitaires.**

C/ Organes des établissements publics de sante

EPSP/EPH/EHS/CHU/EHU/

Un organe délibérant	Des organes d'exécution	Des organes consultatifs
❖ Le Conseil d'administration	❖ Un directeur ❖ Sous directeurs	❖ conseil médical ❖ Conseil scientifique ❖ Comités des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Les organes consultatifs nationaux

Les Comités Médicaux Nationaux :

Ils sont actuellement au nombre de 11. Il s'agit de comités intersectoriels pour la plupart:

Comité Médical National de Lutte contre **les zoonoses** créé par arrêté interministériel du 01.09.1984

Comité Médical National de Lutte contre les **Maladies à Transmission Hydrique** mis en place en 1987

Comité Médical National **Technique de Santé Scolaire** créé par arrêté du 17.05.1993

Comité Médical National **de Médecine du Travail** créé par arrêté du 04.06.1989

Comité Médical National de Lutte contre **la drogue et la toxicomanie** créé par le décret n°92-151 du 14.04.1992

Comité Médical National de Lutte contre **les MST/SIDA** créé en 1989 a été restructuré en 1994 pour devenir intersectoriel (17 secteurs ministériels et 03 associations nationales)

Comité Médical National de Lutte **contre le RAA** créé par arrêté du 16.04.1990.

Au cours de ces deux dernières années, il a été mis en place quatre (04) autres comités intersectoriels:

Le Comité National de **Nutrition** créé par arrêté n°03 du 8 mars 1994

Le Comité National de **Contrôle Sanitaire aux Frontières** créé par arrêté n°35 du 1er juillet 1996

Le Comité **intersectoriel 'Amiante"** créé par arrêté n°86 du 11 septembre 1996

Le Comité Médical National **de Lutte contre l'Envenimation Scorpionique** créé par arrêté n°07 du 23 janvier 1997

Defis? Enjeux? Reformes?

Forces

1. **Personnel médical et paramédical satisfaisant**
2. **Structures en nombre suffisant .**
3. **Organisation pyramidale (EHU, CHU, EHS, EPH, EPSP)**
4. **Couverture géographique homogène malgré étendue du territoire**
5. **Niveau de financement (8% du PIB)**

Defis? Enjeux? Réformes?

Faiblesses

1. Résultats médiocres (taux de mortalité élevés, espérance de vie moyenne, files d'attente, recours aux structures étrangères).
2. Manque de certaines spécialités
3. Gestion archaïque
4. Dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge des malades
5. Système inadapté à la transition épidémiologique (persistance moyenne des maladies transmissibles et apparition prononcée des maladies chroniques)

Conclusion:

Évolution notable avec des changements survenus dans la santé de la population mais des insuffisances restent combler.

Trois objectifs à atteindre:

1/ Élaborer une **organisation** permettant aux intervenants d'agir et interagir pour réaliser des actions clairement définis pour l'amélioration de la santé de la population;

2/ Mettre en place un **système d'information** qui soit une véritable aide à la décision.

3/ **Réglementer** différentes activités de santé par des textes et des guides techniques et consensus.